

DELIRIUM — CAM + TRATAR CAUSA

DEFINIÇÃO E IMPACTO

O QUE É DELIRIUM

- Distúrbio agudo de atenção e cognição com curso flutuante — síndrome de disfunção cerebral aguda
- Características: início agudo, flutuação, déficit de atenção, desorganização do pensamento, alteração de consciência
- Prevalência: 14-56% dos idosos hospitalizados; 60-80% em UTI
- Desfechos: aumento de mortalidade, tempo de internação, demência acelerada, institucionalização
- Subtipos: hiperativo (20% — agitação), hipoativo (25% — mais subdiagnosticado), misto (55%)

CAM — CONFUSION ASSESSMENT METHOD

Critério	Como avaliar	Resultado
1. Início agudo e flutuante	Mudança aguda do estado mental basal, com flutuação ao longo do dia	Presença = 1
2. Desatenção (OBRIGATÓRIO)	Dificuldade de concentração: contar meses ao contrário, segurar atenção	Presença = 1
3. Pensamento desorganizado	Discurso incoerente, muda de assunto, ideias ilógicas	Presença = 1
4. Alteração de consciência	Qualquer estado além de alerta normal (hipervigilante, letárgico, estuporoso)	Presença = 1
Diagnóstico CAM+	1 + 2 (obrigatórios) + 3 OU 4	Sensib. 94%, Especif. 89%

CAUSAS DO DELIRIUM — MNEMÔNICO I-WATCH-DEATH

Causa	Exemplos
Infecção	Pneumonia, ITU, sepse, meningite, endocardite
Withdrawal (abstinência)	Álcool (DT), benzodiazepínicos, opioides
Acute metabolic	Uremia, DRC, Na, Ca, glicose, hepática, tireoidiana
Trauma / TCE	Fratura de quadril, trauma craniano, pós-cirúrgico
CNS pathology	AVC, meningite, encefalite, tumor cerebral
Hypoxia / Hipoperfusão	PCR, IC, TEP, anemia grave, DPOC
Drugs / Deficiências	Opioides, BZD, anticolinérgicos, corticoide; B12, tiamina
Endocrine / Environment	Hipertireoidismo, insuf. adrenal; imobilização, sonda, cateter

DROGAS QUE CAUSAM DELIRIUM — BEERS LIST

SUSPENDER OU REDUZIR

- Anticolinérgicos: prometazina, difenidramina, biperideno, escopolamina, oxibutinina
- Benzodiazepínicos: diazepam, midazolam, lorazepam (especialmente em idosos)
- Opioides: morfina, codeína (especialmente metabólitos em IR)
- Corticosteroides sistêmicos: prednisona, hidrocortisona em altas doses
- H2 bloqueadores: cimetidina (cruzam barreira hematoencefálica)
- Digitálicos: intoxicação digitalica — delirium + náusea + bradiarritmia

TRATAMENTO — NÃO FARMACOLÓGICO É PRIMEIRO

Medidas Não-Farmacológicas (HELP)

- Reorientação contínua: calendário, relógio, familiar
- Mobilização precoce: sentar na beira do leito, deambular
- Privação do sono: ambiente tranquilo, janela aberta, não acordar desnecessariamente
- Hidratação e nutrição adequadas
- Órteses: óculos e aparelho auditivo
- Remover cateteres, sondas e contentções desnecessárias

Farmacológico (quando necessário)

- Haloperidol 0,5-1 mg VO/IM (idoso) — apenas se risco para si/outros
- Quetiapina 12,5-25 mg VO (Parkinson: evitar haloperidol)
- Benzodiazepínico: APENAS na abstinência alcoólica
- NÃO dar BZD para delirium geral (piora e prolonga!)
- Melatonina: melhora ciclo sono-vigília, possível benefício profilático
- Dexmedetomidina: UTI — delirium hiperativo refratário em VM

PREVENÇÃO — BUNDLE HOPE

BUNDLE HOSPITALAR

- ☐ Hidratação adequada — avaliar diariamente; SF se via oral não funciona
- ☐ Orientação — reorientar 3x ao dia; familiar à beira do leito
- ☐ Prevenção de imobilidade — fisioterapia desde o 1º dia de internação
- ☐ Evitar drogas deliriofênicas — revisar prescrições diariamente
- ☐ Sono — não acordar para sinais vitais desnecessários entre 23h e 6h
- ☐ Estimulação sensorial — óculos, aparelho auditivo, televisão durante o dia
- ☐ Screening diário com CAM em todos os idosos hospitalizados

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Para o diagnóstico de delirium pelo CAM, quais critérios são OBRIGATÓRIOS?

- A) Febre + agitação
- B) Início agudo + flutuação, sem desatenção
- C) Início agudo/flutuante + desatenção (+ pensamento desorganizado OU alteração de consciência)
- D) Alucinações visuais + desorientação
- E) ECG alterado + confusão mental

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual subtipo de delirium é o MAIS subdiagnosticado na prática clínica?

- A) Hiperativo (agitação psicomotora intensa)
- B) Misto (flutuação entre hiperativo e hipoativo)
- C) Hipoativo (paciente quieto, letárgico, 'bem comportado')
- D) Alucinatório puro
- E) Catatônico

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Idosa de 80 anos, operada de fratura de quadril, apresenta confusão mental flutuante, piora à noite e dificuldade de atenção desde o 2º dia de pós-operatório. O quadro é mais consistente com:

- A) Depressão reativa à cirurgia
- B) Demência de início súbito
- C) Delirium pós-operatório — início agudo, flutuante, fator precipitante (cirurgia)
- D) Psicose por corticoide
- E) Encefalopatia hepática

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual classe de drogas deve ser EVITADA no tratamento farmacológico do delirium em idosos (exceto na abstinência alcoólica)?

- A) Antipsicóticos típicos (haloperidol) em baixas doses
- B) Benzodiazepínicos — pioram e prolongam o delirium
- C) Melatonina
- D) Inibidores da colinesterase
- E) Quetiapina em pacientes com Parkinson

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual medida NÃO farmacológica tem a maior eficácia na prevenção do delirium hospitalar em idosos?

- A) Administração rotineira de melatonina
- B) Restraint (contenção física) para segurança do paciente
- C) Bundle multicomponente (HELP): reorientação, mobilização precoce, sono, hidratação, órteses
- D) Profilaxia com haloperidol 0,5 mg à noite
- E) Sedação leve com benzodiazepínico para reduzir a agitação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

CAM: critérios obrigatórios = início agudo/flutuante + desatenção. Mais um dos seguintes: pensamento desorganizado OU alteração de consciência. Sensibilidade 94%, especificidade 89% para delirium.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Delirium HIPOATIVO: paciente quieto, letárgico, hipoativo, 'bonzinho' — não chama atenção da equipe. É o mais subdiagnosticado (25% dos casos) e associado ao pior prognóstico (mortalidade maior que o hiperativo).

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Delirium pós-operatório: início agudo após cirurgia, curso flutuante, desatenção, desorientação. Fatores: idoso, fratura de quadril, anestesia, hipotensão intraoperatória, dor, opioides, privação de sono. Tratar causa + medidas não-farmacológicas.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

BZD em idosos com delirium (exceto abstinência alcoólica): PIORAM O DELIRIUM e prolongam a duração. Paradoxalmente aumentam a agitação em idosos. Haloperidol 0,5-1 mg é permitido apenas se risco imediato para si/outros.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Bundle HELP (Hospital Elder Life Program): reorientação, mobilização precoce, evitar privação do sono, hidratação, órteses sensoriais — reduz incidência de delirium em ~30%. É o padrão-ouro de prevenção multicomponente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico